PANCREATITIS AGUDA

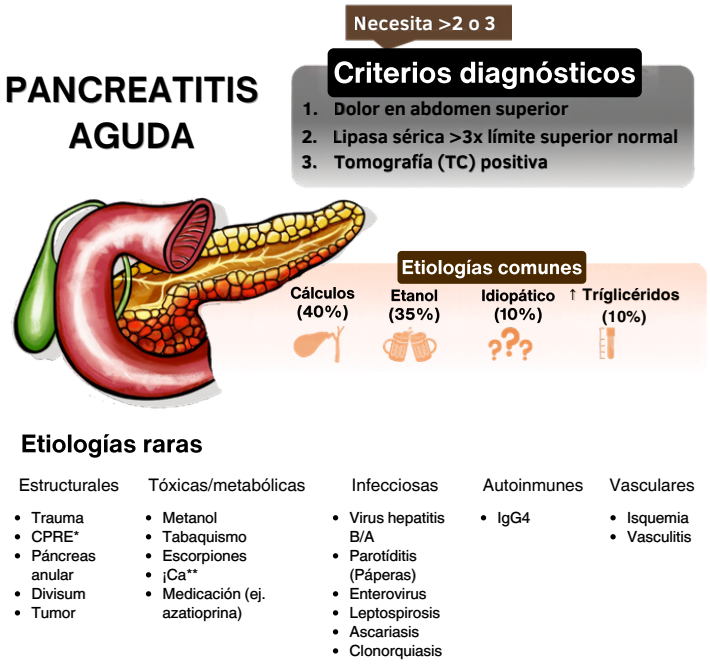
DR. MOISÉS CUKIER

ETIOLOGÍA Y TIPOS

- Causas principales: alcoholismo y litiasis biliar (coledocolitiasis); también medicamentos (tiazidas, furosemida, AZT), CPRE, trauma e hipertrigliceridemia.
- Clasificación: leve (edematosa) vs. severa (hemorrágica); biliar vs. otras causas; temprana vs. tardía.
- Presentación clínica: dolor en epigastrio/mesogastrio irradiado a la espalda, náusea, fiebre (50%); abdomen doloroso pero no en tabla.

LABORATORIOS E IMÁGENES

- Amilasa sérica: alta sensibilidad (95%) pero baja especificidad (50%); se eleva en 2-6h y baja en 48-72h.
- Lipasa sérica: alta sensibilidad (90%) y especificidad (97%); se mantiene elevada 7-14 días.
- Imágenes: ultrasonido de vías biliares/páncreas, TC de páncreas, ultrasonido endoscópico o RM según el caso.



CRITERIOS DE RANSON Y GRAVEDAD

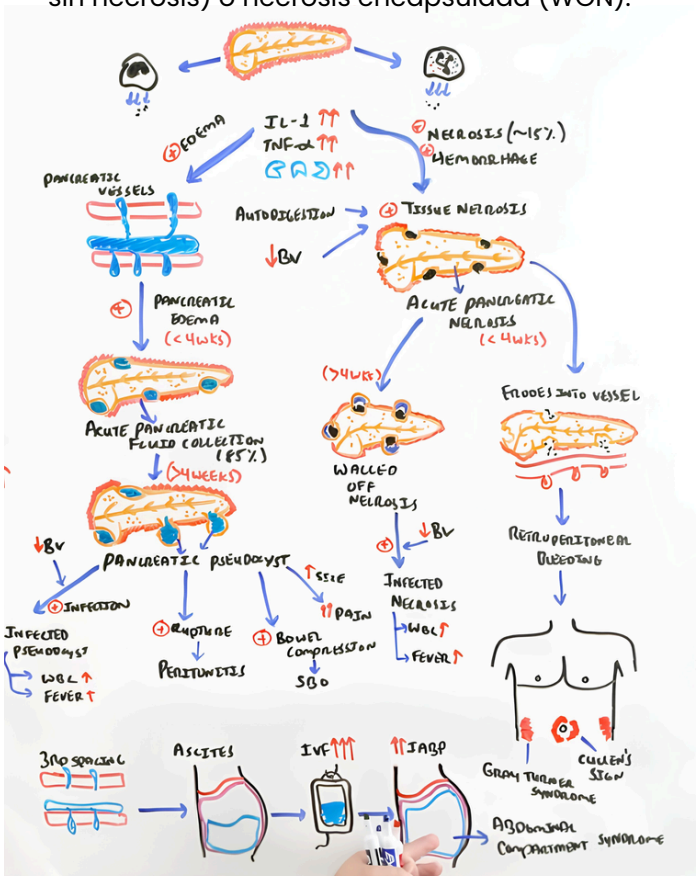
- Criterios de Ranson (1974): diseñados para predecir mortalidad; menos de 3 criterios es leve, más de 3 es severa.
- Mortalidad según el número de criterios: 0-2 → 2%; 3-5 → 20%; 6 o más → más del 50%.
- Alternativas: APACHE II e índice de Baltazar por TC.

BISAP Y OTRAS ESCALAS

- BISAP: BUN >25, alteración mental, SIRS, edad >60 y derrame pleural; ≥3 puntos = mayor mortalidad.
- APACHE II ≥8 y el índice de gravedad por TC (Balthazar) también predicen gravedad.

COMPLICACIONES LOCALES

- <4 semanas: colección líquida peripancreática aguda o colección necrótica aguda.
- >4 semanas: pseudoquiste (pared definida, sin necrosis) o necrosis encapsulada (WON).

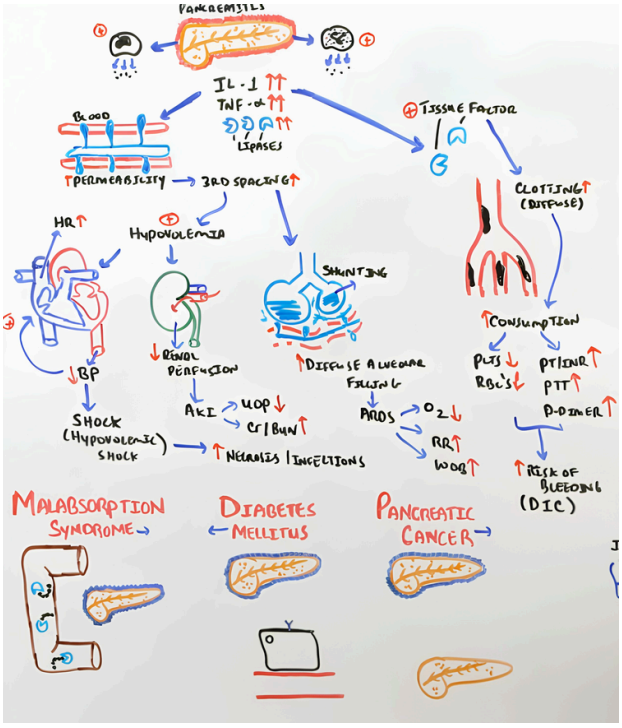


PANCREATITIS AGUDA

DR. MOISÉS CUKIER

COMPLICACIONES SISTÉMICAS

- SDRA, insuficiencia renal, choque, CID, hipocalcemia, hiperglucemia y síndrome compartimental abdominal.



REANIMACIÓN HÍDRICA

- Lactato de Ringer con reanimación moderada guiada por metas (diuresis >0,5 mL/kg/h, FC, BUN y hematocrito); evitar la sobrecarga de volumen.

ANALGESIA

- Prioritaria; los opioides son seguros y no empeoran la evolución.

NUTRICIÓN

- Leve: vía oral temprana en cuanto tolere (24–48 h), sin esperar normalización de enzimas.
- Grave: enteral (nasogástrica o nasoyeyunal) preferida sobre parenteral.

ANTIBIÓTICOS

- No profilácticos; solo ante necrosis infectada sospechada (gas en la TC o deterioro clínico): carbapenémicos o quinolona + metronidazol.

CPRE

- Urgente (<24 h) si hay colangitis; temprana si persiste la obstrucción biliar; no rutinaria en la pancreatitis biliar sin colangitis.

COLECISTECTOMÍA

- Pancreatitis biliar leve: en la misma hospitalización para evitar recurrencias.
- Grave: diferir hasta la resolución de la inflamación y de las colecciones.

MANEJO

- Manejo conservador: líquidos IV, reposo intestinal (NPO), sonda nasogástrica si es necesaria, manejo del dolor (evitar morfina); antibióticos son controversiales.
- Manejo quirúrgico: CPRE si hay coledocolitiasis; colecistectomía 1-2 semanas después; necrosectomía en pancreatitis necrotizante.



NECROSIS PANCREÁTICA

- Estéril: manejo conservador.
- Infectada: abordaje escalonado (step-up): antibiótico → drenaje percutáneo o endoscópico → necrosectomía mínimamente invasiva, idealmente diferida >4 semanas hasta su encapsulación.

PSEUDOQUISTE: INDICACIONES DE DRENAJE

- Síntomas, crecimiento o complicaciones (infección, hemorragia, obstrucción); el tamaño por sí solo no es indicación.
- De elección: drenaje endoscópico transgástrico guiado por USE; alternativa: cistogastrostomía quirúrgica.

PANCREATITIS POR HIPERTRIGLICERIDEMIA

- Triglicéridos >1 000 mg/dL: insulina IV (con dextrosa) y plasmaféresis en casos seleccionados.

PANCREATITIS POST-CPRE

- Prevención: indometacina rectal, hidratación con Ringer y stent pancreático en pacientes de alto riesgo.

PRONÓSTICO

- Leve: mortalidad <1–3%. Grave con falla orgánica persistente: 15–30%; mayor si hay necrosis infectada.